

דום לב ונשימה
PEA/ASYSTOLA
ROSC
ACS
בצקת ריאות
טכיקרדיה צר/רחב
טכיקרדיה יציבה קומפלקס צר
טכיקרדיה יציבה קומפלקס רחב
ברדיקארדיה
התקף אסתמה
החמרה ב COPD
סיוע נשימתי באי ספיקה נשימתית
אנאפילקסיס
ירידה בפרפוזיה שלא על רקע טראומה
חשד ל CVA
פרכוסים

אירובנט $0.5\text{mg}=2\text{cc}$ $1\text{cc}=0.25\text{mg}$ $5\text{mg}/20\text{cc}$
 וונטולין $2.5\text{mg}=0.5\text{cc}$ $1\text{cc}=5\text{mg}$ $100\text{mg}/20\text{cc}$

דום לב ונשימה
 אדרנלין אחרי שוק שני ורביעי
 אמיודורון אחרי שוק שלישי וחמישי $300/150$ מיהול ב 20cc סלין
 שקול מגנזיום סולפט אחרי שוק שלישי (טכיקרדיה רחבה TDP) $1-2\text{gr}$ מיהול 20cc
 שקול סודיום בי קרבונט אחרי שוק שלישי (סימן להיפרקלמיה) 1meq/kg
 אחרי שוק שלישי VC או DSED

PEA/ASYSTOLA
 אדרנלין 1 מ"ג כל $3-5$ דקות
 טפל בגורמים הפיכים (נרקן, נוזלים, חימום, חמצן, מחט, מגנזיום)

ROSC
 הנשמה 10 בדקה.
 אם לא ניתן קודם. אמיודורון העמסה 150mg תוך 10 דקות. אם ניתן אז רק העמסה
 1mg/min
 לא יציב (כ.ל.ב.ה.) – לחץ דם מתחת ל 90 וברדי או טאכי עבור לפרוטוקול מטופל לא יציב
 טכי/בראדי.
 אם לחץ דם מתחת ל 90 סיסטולי ומטופל יציב תן סלין בבולסים חוזרים של 253ml עד
 לחת דם מעל 90 . שקול אדרנלין בפוש $10-20\text{mcg}$ כל 2 דקות. שקול דופמין $5-20\text{mcg/kg/min}$
 אם לחץ דם מעל 90 בצע אקג. טפל בגורמים הפיכים, שקול זונדה, אם חשד לאוטם ונשללה
 חבלת ראש שקול הפרין עדכן יחידת צינטורים
 אם אין חשד לאוטם פנה בדחיפות

לתוכן

תסמונת כלילית חריפה ACS

חמצן במידת הצורך
אם יש סימני ירידה בפרפוזיה תן חמצן, תן אספירין בלעיסה, שקול מתן עירוי נוזלים, בצע אק"ג, שקול מתן דופמין
אם אין סימני ירידה בפרפוזיה שקול מתן חמצן, תן אספירין בלעיסה, בצע אק"ג, שקול מתן ניטרולינגואל SL (התוויות נגד, חובה לחץ דם לפני ואחרי)
שקול פנטניל, זופרן
אם אין חשש ל STEMI המשך ניטור וטיפול במהלך פינוי דחוף לבית חולים קרוב. העבר דיווח
אם יש חשש ל STEMI, שקול הפריין (התוויות נגד), המשך ניטור וטיפול במהלך פינוי דחוף לבית חולים קרוב, הודע ליחידת טיפול נמרץ לב או לחדר צינתורים

בצקת ריאות

אם המטופל באי ספיקה נשימתית – מעבר לפרוטוקול CPAP
אם לחץ דם נמוך מ 100 – שקול פוסיד, שקול דופמין.
אם לחץ דם מעל 100. ניטרולינגואל (חובה אק"ג לפני לבדוק לחץ דם לפני ואחרי. שקול CPAP. תן פוסיד. שקול איזוקט IV, בצע אק"ג. שקול מעבר לפרוטוקול ACS.

טכיקארדיה צרה/רחבה לא יציבה כ.ל.ב.ה

מטופל שידוע שסובל מפרה- אקסיטציה WPW חובה להתייעץ עם רופא לפני טיפול תרופתי.
טכיקארדיה צרה - אין לתת אמיודורון למטופל אסימפטומטי הסובל מפרפור עליות מעל 48 שעות או שמשכו אינו ידוע
צרה וסדירה שקול אדונזין 6mg. אם עזר פינוי.
אם לא עזר שקול היפוך חשמלי. אם לא עזר שקול אמיודורון 150mg. אפשר לתת מנה נוספת אחרי 5-10 דקות. אפשר לנסות היפוך חשמלי נוסף אחרי אמיודורון.

לתוכן

טכיקארדיה צרה יציבה

חובה להתייעץ עם רופא לפני טיפול תרופתי עם המטופל סובל מפרה אקסיטציה WPW מטופרולול רק במקרה שהטכיקארדיה גורמת לתסמינים (פלפיטציות, סחרחורות וכדומה). או במקרה ופינוי ממושך.
מינון 2.5, 5, 5, מקסימלי 15. להמתין 10 דקות בין כל מנה, לבדוק לחץ דם לאחר כל מנה.
קצב סדיר PSVT/SVT בצע גירוי ואגלי, אם לא עזר תן אדונזין 6mg 12mg ו 20ml בפוש מהיר. אם לא עזר שקול מטופרולול
קצב לא סדיר או סדיר ולא PSVT/SVT שקול מטופרולול, אם לא עזר ולא סימפטומטית פינוי. אם לא עזר וסימפטומטית שקול אמיודורון, שקול היפוך חשמלי.

טכיקארדיה רחבה יציבה

חובה להתייעץ עם רופא לפני טיפול תרופתי עם המטופל סובל מפרה אקסיטציה WPW אמיודורון העמסה 150mg. אפשר לחזור על מנת העמסה. מנת אחזקה 1mg/min.
קצב סדיר, שקול אדונזין 6mg 12mg ו 20ml בפוש מהיר.
אם לא עזר או טכיקארדיה לא סדירה שקול אמיודורון, שקול היפוך חשמלי, שקול מגנזיום סולפט (רחבה, פולימורפית לא סדירה)

לתוכן

בראדיקארדיה

אם בראדיקארדיה סימפטומטית, שקול אטרופין 1mg. כל 3-5 דקות עד 3m. אם לא עזר תן אדרנלין, או דופמין, או בצע קיצוב חיצוני, אפשר לשלב בין הטיפולים
אם בראדיקארדיה לא סימפטומטית חבר קוצב חיצוני STANDBY. בצע אק"ג אם לא בוצע עדיין.

המשך ניטור וטיפול בזמן פינוי לבית חולים

לתוכן

אסתמה

קל – אינהלציה אירובנט/ונטולין, סולומדרול. אינהלציה נוספת וונטולין קשה – אדרנלין SC, אינה אירובנט/ונטולין, סולומדרול. אינהלציות חוזרות ארו/וונט. שקול מגנזיום סולפט
אי ספיקה – אדרנלין IM, אינהל ארו/וונט, מגנזיום סולפט, שקול CPAP, אינה חוזרות ארו/וונט
בפינוי סליין בקצב 20ml/min, עד 500ml.

החמרה ב COPD.

לשמור סטורציה באזור 92-94
שקול סיוע ב CPAP, שקול אינהלציה ארו/וונט מנה חד פעמית, שקול סולומדרול IV בצע אקג
לכל אורך הטיפול והפינוי שקול מעבר לנתיב אויר מתקדם.

סיוע נשימתי באי ספיקה נשימתית

סיוע נשימתי אי ספיקה נשימתית
מתאים לאי ספיקה נשימתית מאיימת.
התוויות - מטופל בהכרה ומשתף פעולה.
התוויות נגד- לחץ דם מתחת ל 100. הפרשות כוויות, חוסר שיתוף פעולה חוסר הכרה
הסבר למטופל על הקושי. השג את הסכמתו. הרכב, כוון ל 5 סמ מיים. עודדג את המטופל.
אם לא עוזר כוון ל 10 סמ מים עד הוסף עד שיעזור בפינוי לנסות להוריד לאט בחזרה
בכל מקרה של החמרה במצב להוריד את המסכה ולעבור לטובוס.

לתוכן

אנאפילקסיס

אינהלציה רק אם יש תסמיני B. אירובנט רק לנוטלי חסמי בטא. דופמין רק אם סימני
היפופרפוזיה אחרי אדרנלין ונוזלים
קל – שקול אינה ונטולין, שקול הוספת אירובנט, שקול סולומדרול, שקול נוזלים 1l/hr
אם לא חל שיפור אדרנלין IM, שקול אינה ונטולין, שקול הוספת אירובנט, תן סולומדרול.
תן עירוי 1L/hr, המשך לפינוי.
קשה – תן אדרנלין IM, שקול אינה ונטולין, שקול הוספת אירובנט, תן סולומדרול, תן
סליין 2-3L/hr.
אם לא חל שיפור. שקול אדרנלין IV 10-20mcg ב PUSH כל 2 דקות, שקול דופמין,
המשך עירוי, המשך לפינוי
דום לב- בצע החייאה מלאה תן אדרנלין IV, תן סליין 4-5L/hr, שקול מעבר ל ROSC,
שקול מעבר להמנעות פעולות החייאה.

ירידה בפרפוזיה שלא מטרומה

אבחנה מבדלת

גורם קרדיוגני – הפרעת בקצב או בהולכה, איספיקת לב, תסחיף ריאתי מסיבי, טמפונדה לבבית.
גורם היפולמי או המורגי – הקאות, שלשולים, פוליאוריה, דם GI.
גורם אחר – ספסיס, תגובה אלרגית (אנפילקסיס), איספיקת אדרנל

מטופל לא בשוק שקול חמצן, שקול נוזלים, שקול אקמול IV

אם שוק קרדיוגני – מעבר לפרוטקול מתאים

אם יש גודש (וריד צוואר, גודש ריאתי, בצקת) – אדרנלין IV

אם אין גודש, שקול חמצן תן נוזלים

אם שוק מסיבה אחרת – שקול הקסקפרון, סולומדרול, אדרנלין IV, דופמין.

אם ספסיס – שקול חמצן, אקמול IV, אדרנלין, תן הרטמן

אחרי טיפול יל פי הבחנה מבדלת פנה בדחיפות לביתחולים

לתוכן

חשד ל CVA

מתי הופיעו הסימנים (פחות מ 4.5 שעות)
אבחנה מבדלת - האם אחרי פרכוס, חום גבוה, השפעת תרופות, הפרעות מטבוליות
בדיקת FAST-ED
בדיקת סוכר, בדיקת לחץ דם. אם לחץ דם גבוה.
מתן לבטלול 20mg בפוש איטי בכל 5-10 דקות מינון ממצטבר לא יעלה על 300mg חשוב
להוריד לחץ דם לאט כדי למנוע החמרה באיסכמיה.
בכל מטופל עם חשד לאירוע מוחי חד ולחץ הדם גדול מ 220/140
יעד הטיפול 180/100
במטופל מועמד לטיפול טרומבולטי, ולחץ דם מעל 185/110
התוויות נגד. ברדיקארדיה, חסם מדרגה II ומעלה.
קבע יעד פינוי

לתוכן

פרכוס

דורמיקום מינון למתן ב 5mg IV. מינון למתן ב 10mg IM. מינון למתן ב 10mg IN
אם ערכי הסוכר בדם נמוכים מ-60% mg, יש לתת גלוקוז ב IV (25gr) של תמיסת גלוקוז
ברכוז 25%.

לתוכן